

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALAS DE DEPRESIÓN, ANSIEDAD Y ESTRÉS (DASS-42)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación Dimensional y Modelo Tripartito del Afecto Negativo

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés de 42 reactivos (DASS-42).
Nombre Original (Inglés)	<i>Depression Anxiety Stress Scales (DASS-42)</i> (Lovibond & Lovibond, 1995).
Autores del Diseño Original	Drs. Sydney H. Lovibond y Peter F. Lovibond, Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW), Australia.
Adaptaciones al Español	Bados, Solanas & Andrés (2005, España); Román, Santibáñez & Vinet (2016, Chile); Daza et al. (2002, EE.UU.).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Evaluación dimensional de la severidad del distrés emocional.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de autoinforme estructurado de 42 ítems con escala Likert de severidad/frecuencia.
Población Diana y Rango	Adolescentes (≥ 14 años) y adultos en contextos clínicos asistenciales, comunitarios y laborales.
Tiempo de Administración	8 a 12 minutos (autoadministrado o aplicado en entrevista clínica guiada).
Régimen de Licencia	Dominio público científico (Psychology Foundation of Australia). Libre uso asistencial y de investigación.

2. MARCO TEÓRICO: EL MODELO TRIPARTITO Y LA EVALUACIÓN DIMENSIONAL

El DASS-42 fue desarrollado empíricamente por Lovibond y Lovibond para superar una de las mayores limitaciones de la psicometría clínica clásica: la elevada correlación espuria y el solapamiento diagnóstico entre las medidas tradicionales de depresión y ansiedad (como el BDI, el HAM-D o el STAI), que solían arrojar correlaciones superiores a $r = 0.70$ debido a reactivos inespecíficos de malestar general.

Fundamentado en el modelo tripartito de las emociones negativas formulado por Clark y Watson (1991), el DASS operacionaliza y diferencia tres constructos clínicos independientes pero relacionados:

- Depresión (Bajo Afecto Positivo):** Mide la anhedonia profunda, la pérdida de motivación vital e iniciativa, la disforia, la devaluación personal, la autodenigración y la desesperanza existencial hacia el futuro.
- Ansiedad (Hiperactivación Fisiológica):** Mide los síntomas de activación autonómica del sistema nervioso simpático (taquicardia, disnea, sudoración no térmica, temblores musculares, sequedad bucal) y el miedo subjetivo o aprensión ante el descontrol o pánico.
- Estrés (Tensión y Activación Crónica Inespecífica):** Constituye la principal innovación clínica del DASS. Evalúa un estado persistente de sobreactivación neurovegetativa, baja tolerancia a la frustración, impaciencia, labilidad emocional, irritabilidad ante interrupciones y dificultad continuada para relajarse ("estar siempre al límite").

3. ESTRUCTURA FACTORIAL Y ASIGNACIÓN ÍTEM A ÍTEM (14 ÍTEMS POR FACTOR)

Los 42 ítems se evalúan con respecto a la **última semana** mediante una escala Likert de 4 puntos: **0** = No se aplicó a mí en absoluto; **1** = Se aplicó un poco o en parte del tiempo; **2** = Se aplicó bastante o una buena parte del tiempo; **3** = Se aplicó mucho o la mayor parte del tiempo. Todos los reactivos se puntúan de forma directa (sin ítems invertidos).

Subescala	Ítems	Números de Ítem	Constructos Específicos Evaluados
Depresión	14	3, 5, 10, 13, 16, 17, 21, 24, 26, 31, 34, 37, 38, 42	Disforia, anhedonia, desesperanza, devaluación de la vida, falta de incentivo, autodesprecio e inercia motora/conductual.
Ansiedad	14	2, 4, 7, 9, 15, 19, 20, 23, 25, 28, 30, 36, 40, 41	Activación autonómica simpática, efectos músculo-esqueléticos, ansiedad situacional y temor subjetivo al pánico o ridículo.
Estrés	14	1, 6, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 27, 29, 32, 33, 35, 39	Dificultad para relajarse, tensión nerviosa sostenida, sobrecarga mental, irritabilidad, impaciencia y reactividad exagerada.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

Evidencia Científica de Fiabilidad, Validez Dimensional y Puntos de Corte Clínicos

4. EVIDENCIA DE FIABILIDAD Y VALIDEZ (INTERNACIONAL Y EN ESPAÑOL)

Consistencia Interna (Muestra Original)	Lovibond & Lovibond (1995, N = 2.914 no clínicos): Depresión $\alpha = 0.91$, Ansiedad $\alpha = 0.84$, Estrés $\alpha = 0.89$. Escala total $\alpha = 0.94$.
Muestras Clínicas Psiquiátricas	Antony et al. (1998, N = 437 con trastornos afectivos y de ansiedad): Depresión $\alpha = 0.96$, Ansiedad $\alpha = 0.89$, Estrés $\alpha = 0.93$.
Validación en Español	Bados et al. (2005) y Román et al. (2016): Alfas de Cronbach excelentes (Depresión 0.92, Ansiedad 0.85, Estrés 0.89) y Omega de McDonald $\omega > 0.88$.
Estabilidad Temporal	Confiabilidad test-retest a 2-4 semanas altamente satisfactoria ($r = 0.71$ a $r = 0.82$; Shayan et al., 2021: $r = 0.799$ a 0.822).
Validez Convergente	Depresión-DASS con BDI ($r = 0.74 - 0.80$) y HAM-D ($r = 0.71$); Ansiedad-DASS con BAI ($r = 0.70 - 0.81$) y STAI-R ($r = 0.68 - 0.75$).
Validez Estructural (CFA)	Análisis factorial confirmatorio valida la solución trifactorial con índices robustos: CMIN/df < 3.0 , RMSEA = $0.048 - 0.052$, CFI > 0.92 , SRMR < 0.045 .

5. BAREMOS OFICIALES Y RANGOS DE SEVERIDAD (LOVIBOND & LOVIBOND, 1995)

Cada subescala tiene una puntuación directa que oscila entre **0 y 42 puntos** (suma simple de los 14 ítems correspondientes). Los rangos no representan categorías diagnósticas cerradas, sino desviaciones respecto a la media poblacional normalizada:

Nivel de Severidad	Depresión (D)	Ansiedad (A)	Estrés (S)	Interpretación Clinimétrica
Normal	0 – 9	0 – 7	0 – 14	Sintomatología ausente o dentro de los márgenes normales de variación afectiva.
Leve	10 – 13	8 – 9	15 – 18	Manifestaciones incipientes; no suelen comprometer gravemente la funcionalidad.
Moderado	14 – 20	10 – 14	19 – 25	Malestar emocional significativo con interferencia objetiva en la vida cotidiana.
Severo	21 – 27	15 – 19	26 – 33	Cuadro sintomático intenso con marcada incapacidad laboral, académica o social.
Extremadamente Severo	28 o más	20 o más	34 o más	Sufrimiento psíquico extremo; descompensación clínica y alto riesgo psiquiátrico.

Relación y Equivalencia entre el DASS-42 y la Versión Abreviada DASS-21:

El DASS-21 contiene exactamente 7 ítems por subescala seleccionados de la versión de 42 ítems. Para proyectar la puntuación de un DASS-21 sobre los baremos normativos del DASS-42, se aplica la regla de transformación: $PD_{DASS-42} \equiv PD_{DASS-21} \times 2$. El DASS-42 se prefiere cuando se requiere máxima fidelidad psicométrica, evaluación ítem por ítem de síntomas vegetativos específicos o seguimiento terapéutico fino.

6. ALGORITMO CLÍNICO DE INTERPRETACIÓN Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

La lectura simultánea de las tres curvas del DASS-42 permite trazar perfiles psicopatológicos discriminativos:

- **Perfil Depresivo Puro (D ≥ 21 , A ≤ 9 , S ≤ 18):** Anhedonia profunda, abatimiento, inhibición motora y autodesprecio sin agitación autonómica. Compatible con Episodio Depresivo Mayor o Distimia.
- **Perfil Fóbico / Pánico (A ≥ 15 , D ≤ 13 , S variable):** Hiperactivación simpática brusca (disnea, taquicardia, temblores) y aprensión al pánico. Compatible con Trastorno de Pánico o Agorafobia.
- **Perfil de Sobrecarga / Estrés (S ≥ 26 , D ≤ 13 , A ≤ 9):** Tensión constante, impaciencia y labilidad por sobreexigencia ambiental. Compatible con Síndrome de Burnout o Trastorno de Adaptación.
- **Perfil Mixto Severo (D ≥ 21 , A ≥ 15 , S ≥ 26):** Afectación simultánea en los tres ejes emocionales. Sugiere comorbilidad severa, depresión ansiosa o descompensación afectiva.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

Formulación de Caso, Alertas Críticas de Seguridad y Bibliografía Seminal en Formato APA 7

7. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERPRETACIÓN Y SEGUIMIENTO TERAPÉUTICO

Anamnesis y Motivo de Consulta: Paciente mujer de 35 años, jefa de proyectos en empresa tecnológica. Acude a consulta de salud mental derivada por su médico de atención primaria refiriendo insomnio de conciliación, contracturas cervicales, irritabilidad laboral y “opresión en el pecho” durante las reuniones ejecutivas. Teme padecer un problema cardíaco tras descartarse patología orgánica.

Puntuaciones Directas Obtenidas en el DASS-42:

- **Depresión:** PD = 6 puntos → **Rango Normal** (0–9). Conserva capacidad de disfrute con su familia, metas a futuro intactas y autoestima preservada.
- **Ansiedad:** PD = 13 puntos → **Rango Moderado** (10–14). Marcada por reactivos autonómicos: boca seca (ítem 2: 2), falta de aire (ítem 4: 2), sudoración (ítem 19: 2) y palpitaciones (ítem 25: 2).
- **Estrés:** PD = 29 puntos → **Rango Severo** (26–33). Elevaciones máximas en irritabilidad (ítem 11: 3, ítem 27: 3), impaciencia (ítem 14: 3), dificultad para relajarse (ítem 8: 3) y tensión nerviosa (ítem 33: 3).

Juicio Clínico y Plan de Intervención: El perfil tripartito descarta un cuadro depresivo unipolar. Se formula un **Trastorno de Adaptación con Síntomas Ansiosos y Mixtos de Estrés (CIE-11: 6B43)** desencadenado por sobrecarga ocupacional. Se implementa un protocolo TCC en 10 sesiones con entrenamiento en respiración diafragmática (para desactivar la respuesta simpática refleja), reestructuración cognitiva de creencias de autoexigencia y asertividad laboral. En el retest a las 8 semanas, las puntuaciones se redujeron a: Depresión = 4 (Normal), Ansiedad = 5 (Normal), Estrés = 13 (Normal).

8. ALERTAS CRÍTICAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y NORMAS DEONTOLÓGICAS

ALERTA ROJA PRIORITARIA: CRIBADO DE RIESGO SUICIDA (ÍTEMS 21, 37 Y 38)

El DASS-42 no es una escala diagnóstica de conducta suicida; sin embargo, tres ítems de la subescala de Depresión exploran constructos de alto riesgo:

- **Ítem 21:** “Pensé que la vida no valía la pena”.
- **Ítem 37:** “No veía nada en el futuro con lo cual tener esperanzas” (desesperanza de Beck).
- **Ítem 38:** “Sentí que la vida no tenía sentido”.

Cualquier puntuación ≥ 2 en estos ítems exige una **evaluación clínica inmediata del riesgo autolítico** mediante entrevista especializada (p. ej., Escala Columbia C-SSRS) y la activación de los protocolos institucionales de protección.

No Sustitución Diagnóstica: El DASS-42 evalúa severidad de dimensiones sintomáticas; puntuaciones elevadas requieren correlato con juicio clínico estructurado (DSM-5-TR / CIE-11). **Uso en Investigación y Monitorización:** Su sensibilidad métrica y el rango de 0 a 42 puntos lo convierten en un instrumento de elección para monitorizar ensayos clínicos y curvas de respuesta a psicoterapia.

9. REFERENCIAS CIENTÍFICAS SEMINALES (NORMA APA 7ª EDICIÓN)

1. Lovibond, S. H., & Lovibond, P. F. (1995a). *Manual for the Depression Anxiety Stress Scales* (2nd ed.). Sydney: Psychology Foundation of Australia.
2. Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995b). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. *Behaviour Research and Therapy*, 33(3), 335–343.
3. Clark, L. A., & Watson, D. (1991). Tripartite model of anxiety and depression: Psychometric evidence and taxonomic implications. *Journal of Abnormal Psychology*, 100(3), 316–336.
4. Antony, M. M., Bieling, P. J., Cox, B. J., Enns, M. W., & Swinson, R. P. (1998). Psychometric properties of the 42-item and 21-item versions of the Depression Anxiety Stress Scales in clinical groups and a community sample. *Psychological Assessment*, 10(2), 176–181.
5. Crawford, J. R., & Henry, J. D. (2003). The Depression Anxiety Stress Scales (DASS): Normative data and latent structure in a large non-clinical sample. *British Journal of Clinical Psychology*, 42(2), 111–131.
6. Bados, A., Solanas, A., & Andrés, R. (2005). Propiedades psicométricas de la versión española de las Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS). *Psicothema*, 17(4), 679–683.
7. Román, F., Santibáñez, P., & Vinet, E. V. (2016). Uso de las Escalas de Depresión Ansiedad Estrés (DASS-21) adaptadas al español en población chilena. *Revista Médica de Chile*, 144(9), 1174–1181.
8. Shayan, N., et al. (2021). Psychometric Properties of the Dari Version of Depression, Anxiety and Stress Scales-42 (DASS-42) in a Non-clinical Population. *Bezmialem Science*, 9(3), 356–362.